

有散步、慢跑、做广播体操、骑带测力器的自行车、游泳等, 劝告患者进行全身性的有氧运动。但是, 在繁忙的日常生活中, 没有时间进行特殊的运动时, 可用走楼梯代替乘电梯、上下班乘坐汽车提前一站下来步行等, 让患者理解, 在日常生活中发挥主动性锻炼也是有效果的。步行计数器、热卡计算器对于日常生活中掌握运动量是很有用的。

运动疗法实施中的注意事项 ①饮食疗法的并用。假如不进行饮食疗法的并用, 糖尿病及肥胖均不能得到良好的控制。②禁烟, 还要进行酒的限制。③对正在实行药物疗法的病例, 如胰岛素治疗的病人要防止发生低血糖等, 对个别病人应对症处理。④也要进行一般注意事项的指导, 如准备、整理运动的实施及运动鞋、服装等等。⑤饮食限制和运动效果是有限度的, 实施 3~6 个月还没有看到病情改善的效果时, 应适当地给予某种药物。

(蒋万冰摘 吴致勋校)

049 抑郁症对脑卒中后功能转归的影响 [英] /Herrmann N ... // Stroke .-1998, 29 .-618~624

作者为了评估抑郁症的发生率及其与临床的相关性以及抑郁症症状对脑卒中康复的影响, 随机选择了加拿大多伦多大学与 Sunnybrook 卫生中心的一组确诊为脑卒中病人进行前瞻性研究。

方法 全部病人均符合世界卫生组织 (WHO) 和国家神经疾病以及脑卒中研究院有关脑卒中诊断标准, 但不包括蛛网膜下腔出血和脑干卒中病人。这组病人都在入院时, 经 CT 单光子发射计算机断层显像仪 (SPECT), 标准神经学科和认知检查。脑卒中后 3 个月和 1 年后, 均用 Montgomery Asberg 的抑郁评级量表 (MADRS); 和 Zung 氏抑郁自我评级量表 (SDS); 对抑郁症的症状进行评估, 还应用功能独立性测量表来检测功能的转归。再用牛津残疾量表评估病人

残废情况。

结果 作者共评估入院 436 例病人, 平均 74.9 ± 11.6 岁, 其中脑卒中后 3 个月者 150 例, 卒中后 1 年者 136 例。在脑卒中后 3 个月的病人明显的抑郁症状占 22% (SDS) ~27% (MADRS); 1 年后则为 21% (SDS) ~22% (MADRS)。抑郁症状明显者, 神经性损害就更严重 ($P < 0.008$), 尤其以女性病人更突出 ($P < 0.05$)。而且过去往往有抑郁病史 ($P < 0.03$)。但是抑郁症与年龄、病灶体积或病灶所在的大脑半球无相关性。脑卒中 3 个月后, 病人的抑郁症状与功能转归以及后遗残废相关 (前者 $\gamma = -0.31$, $P < 0.001$; 后者 $\gamma = 0.41$, $P < 0.001$), 1 年后这种相关性仍存在 (前者 $\gamma = -0.28$, $P < 0.01$; 后者 $\gamma = 0.35$, $P < 0.001$)。

讨论 本研究的主要优点在于它追踪卒中后的时间长, 而且随访计划和组织很严密, 并且统一应用了有效而且可信的检测抑郁的量表。结果证实是女性病人与抑郁显著相关, 大脑半球卒中量表 (HSS) 积分和抑郁史, 均有相关性。另外, 有关抑郁发生率的结果与其它社区性的研究结果相似, 即接近 33% 的病人能够恢复, 但接近 40% 的病人仍持续有抑郁症状。

结论 抑郁症与功能转归呈相关性。从此研究的抑郁症发生率来看, 及时诊断和治疗抑郁症对脑卒中病人的康复是至关重要的。

(胡叶文摘 盛洁华校)

050 1 例因药物相互作用而致患者衰弱的护理体会 [英] /Lilley L L ... // Am J Nurs .-1998, 98 (4) .-10

患者, 78 岁, 因喉痛、脓痰、咳嗽、头晕和发热等上呼吸道感染症状来院就诊。医生给予红霉素 500 mg 每 6 h 口服 1 次。由于该病人有家庭遗传性心脏病且体重超重, 血脂高, 故服用洛伐他丁 (Lovastatin; 美降脂, 20 mg。服红霉素后, 其上呼吸道症状明

显改善,但出现乏力、肌肉疼痛,血压 18.1/11.7 kPa,脉搏 82 次/min,呼吸 18 次/min。由此,查询有关药理学资料发现,红霉素与洛伐他丁相互作用会导致横纹肌溶解。红霉素是酶系统的抑制剂,而洛伐他丁则是酶解物,红霉素能抑制洛伐他丁的代谢使血清洛伐他丁含量增高,而洛伐他丁则引起横纹肌溶解。对于需同时服用上述两种药物者,护士应全面了解横纹肌溶解的症状和表现,嘱病人注意服药后的反应,如上下肢运动情况,如果出现肌肉痛或乏力等,应及时报告医生。另外,肌酸激酶含量是肌肉损伤的指标,如果患者的肌酸激酶含量增高,或怀疑横纹肌溶解,则应终止药物治疗,报告医生进行处理。

由上例事件看出,护士执行医嘱时,应先详细了解各药物的剂量、用法以及药物间的相互作用,稍有不慎便有可能导致药物中毒和用药错误,因此应避免盲目执行医嘱,与病人交流才能防止此类药物相互作用的发生。

(李丽芬摘 黄秋燕校)

051 整体护理中有关问题解答 [英] / Acee A M // Am J Nurs .-1998, 98 (8) .-36~37

Lavigne 是 45 岁的晚期乳腺癌患者,并已发生了骨转移及肝转移,疼痛的处置对她来说一直是个难题,当护士接近她时,她不愿意谈起“临终”问题。作者以 Lavigne 为实例,通过回答的形式对整体护理进行解释,并对其潜在的临床意义进行说明。

问:医学术语 healing (痊愈) 和 curing (治愈) 有什么区别?

答:McGlone 将治愈定义为通过手术、药物或机械性的干预使症状减轻,或疾病过程的终结或使病情得到抑制,治愈并不重视病因及诱发因素。但在病因找出之前,疾病继续发展以致出现新的症状者并不少见。

痊愈就不同了,它可以是机体的自愈,通常是机体自身通过一系列深刻变化,(对待内

外刺激的) 反应机制的苏醒。McGlone 指出,痊愈和治愈在相互矛盾和相互作用方面有着明显的区别。例如:对于医护人员来说,治愈主要是针对疾病本身及其产生的症状而言,而痊愈则是针对发生疾病的主体即整个人而言。需要指出的是,一个病人的病治愈了,但他本身体质尚未痊愈,反之亦然。在感情及身体上受到限制,甚至必将死亡者,其痊愈的潜力也是巨大的。人们需要对“痊愈”进行重新认识。Newman 将这种观念的变革称为一种新的“模式”,即身体内部能量的重新分配及形式上的交互变化。Rofers 把一个人作为有机的整体,把健康痊愈与疾病治愈看作 2 个对等的方面,如此划分的意义是基于对生命活动这一广泛概念过程的理解。

McGlone 指出,痊愈来自于或伴随着自身的有机调节,医护人员没办法确定。痊愈取决于病人战胜疾病的信心,他还指出,痊愈的过程还取决于病人的生活经验,以及外伤、疾病和其他创伤给身体的刺激和影响。如此看来,生病并不是坏事,而是促动因素。通过生病使人们认识到,机体在生理上、心理上需要重新调整人们的生活方式、行为以及对生活的态度,需要作出某种程度的改变。

问:对于正在从事护理职业的人来说,整体护理有什么重要性?

答:最近的研究有助于医护人员理解机体与精神的内在联系。Dossey 曾经指出:治疗疾病时只重视肉体本身,而忽视精神方面,或忽视生理方面的做法都是不全面的。整体治疗的逐渐普及及其有效性、合理性,正是现今不健全的健康护理所需要采纳的。整体护理人员根据病人生理、心理、精神方面的需要进行护理,整体护理并不否定传统护理的有效性,但可充实、丰富护理的范畴,使之更有助于促进病人的康复。

患者 Lavigne 的顾虑和痛苦,经整体护理后,即在护理人员教会其意念放松技术后,得以缓解、控制。她的症状的减轻,使她更